PROPUESTA PRELIMINAR · CONFIDENCIAL

# Congreso Internacional de Salud Pélvica y Urogenital

*Conectar · Integrar · Investigar · Acompañar*

Connecting Science, Surgery and Therapeutic Innovation for the Future of Medicine. Los mejores especialistas internacionales de cada área, en una red al servicio del paciente.

**Barcelona · Auditori AXA**

17–20 de febrero de 2028 · fechas previstas

**WA LAM para l'Associació Catalana d'Urologia**

**4**
DÍAS

**60**
SESIONES

**600**
PLAZAS

**2028**
BARCELONA

EL PROYECTO EN 30 SEGUNDOS

# Un congreso internacional que crea una red al servicio del paciente.

Lo mejor de cada especialidad: referentes nacionales e internacionales en urología, ginecología, coloproctología, fisioterapia, osteopatía, nutrición, psicología e investigación, alrededor del mismo paciente.

**4**

**JORNADAS**

Del jueves 17 al domingo 20 de febrero de 2028

**60**

**SESIONES CIENTÍFICAS**

Conferencias, mesas y casos clínicos integrados

**13**

**TALLERES PRÁCTICOS**

De 1 a 4 horas, en salas paralelas y grupos reducidos

**600**

**PLAZAS PRESENCIALES**

Auditori AXA · Avinguda Diagonal, Barcelona

**+70**

**REFERENTES INTERNACIONALES**

Los mejores especialistas de cada área temática

**Online**

**STREAMING EN DIRECTO**

Todas las ponencias, para quien no pueda desplazarse

LA VISIÓN

# Unir lo que el paciente vive como uno, aunque el sistema lo estudie por separado.

**La pregunta central:** ¿qué ocurre cuando urología, ginecología, coloproctología, fisioterapia, osteopatía, nutrición y psicología se conocen y trabajan en red alrededor del mismo paciente?

### EN MUCHOS CONGRESOS

- Un único eje dominante: técnica, investigación o medicina
- Especialidades que no conocen lo que aportan las demás
- Derivaciones sin un objetivo clínico definido

### LO QUE PROPONEMOS

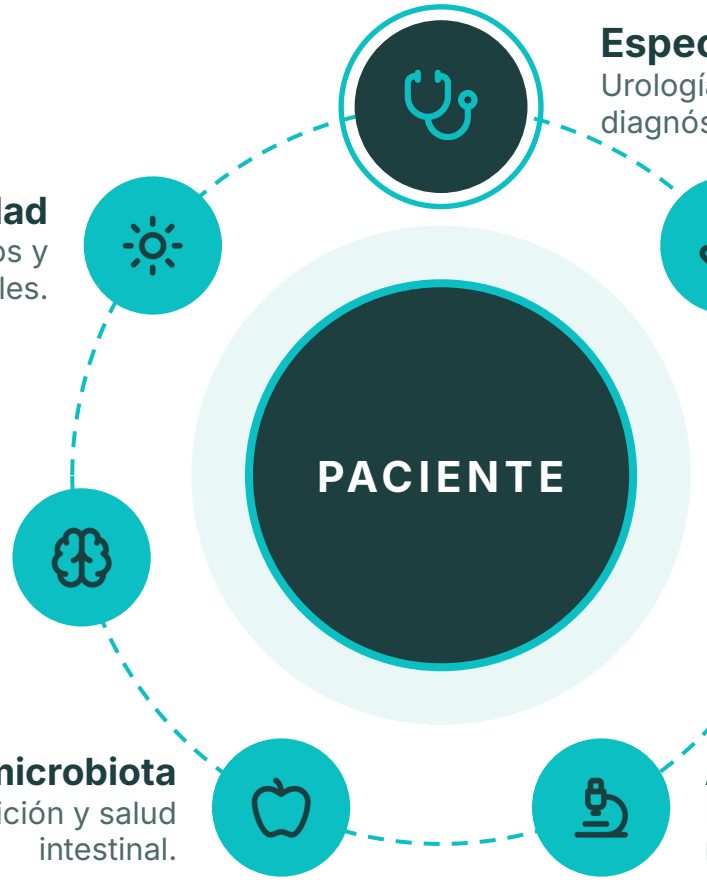
- Las especialidades médicas como eje clínico del programa
- Fisioterapia, osteopatía, nutrición y psicología en diálogo con los especialistas
- Casos clínicos compartidos y una red de derivación estable

### RESULTADO ESPERADO

- Profesionales de referencia que se conocen y colaboran
- Derivaciones con indicación precisa, antes y después de la intervención
- Mejores resultados terapéuticos y calidad de vida

*El especialista mantiene el diagnóstico y el tratamiento; la red amplía sus resultados: cada profesional desde su ámbito de competencia.*

# Modelo de atención integrada




**Especialidad médica**
Urología, ginecología o coloproctología: diagnóstico y tratamiento.

**Terapia manual y rehabilitación**
Fisioterapia del suelo pélvico y osteopatía visceral y craneal.

**Postura, movilidad y respiración**
Valoración postural y su influencia sobre los órganos; ejercicio terapéutico individualizado.

**Avances científicos**
Últimas investigaciones: optogenética, mitocondrias y reparación tisular.

**Nutrición y microbiota**
Pautas dietéticas, crononutrición y salud intestinal.

**Estrés y dolor crónico**
Programa MBSR, apoyo psicológico y regulación del sistema nervioso.

**Calidad de vida y longevidad**
Higiene del sueño, ritmos circadianos y hábitos saludables.

- Tratamiento médico de la patología
- Abordajes complementarios en red

*Cada profesional interviene desde su ámbito de competencia, de forma coordinada, para potenciar los resultados del tratamiento y la calidad de vida.*

# Un congreso de alto nivel con un motor formativo y un legado.

### CONGRESO PRINCIPAL

- 4 jornadas presenciales y en streaming
- Conferencias y mesas de diálogo
- Casos clínicos integrados
- Comunicaciones orales y pósteres

### FORMACIÓN PRÁCTICA

- 13 talleres de 1 a 4 horas
- Salas paralelas y grupos reducidos
- Docentes de referencia
- Inscripción aparte y plazas limitadas

### LEGADO

- Red asistencial estable entre profesionales
- Grabaciones disponibles durante 12 meses
- Comité científico y premios a la investigación
- Base para las siguientes ediciones

### FORMATO DIARIO ORIENTATIVO

| | |
|---|---|
| **08:30** | Acreditaciones y bienvenida |
| **09:30** | Bloque de mañana: conferencias y mesa redonda · pausa café a media mañana |
| **13:30** | Comida, networking y pósteres |
| **15:00** | Bloque de tarde: conferencias y casos clínicos integrados · pausa café |
| **17:30** | Comunicaciones orales · talleres prácticos en salas paralelas |
| **19:00–19:30** | Cierre de la jornada |

LA SEDE

# Auditori AXA: un auditorio de referencia en la Diagonal.



### AFORO

600 plazas presenciales en el auditorio principal.

### UBICACIÓN

Avinguda Diagonal, 547. Eje financiero y empresarial de Barcelona.

### CONECTIVIDAD

Ubicación céntrica, bien comunicada con transporte público y con el aeropuerto internacional.

### FORMATO HÍBRIDO

Emisión en directo de todas las ponencias para los inscritos online.

# Cuatro ejes clínicos, sesenta sesiones.

DÍA 1 · JUEVES 17 DE FEBRERO

**18** sesiones

## I. Patologías pélvicas y urogenitales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Endometriosis | 10 | Andrología y medicina sexual |
| 2 | Adenomiosis e imagen | 11 | Hiperplasia benigna de próstata |
| 3 | Vulvodinia y dermatosis vulvares | 12 | Cadera, ingle y pubalgia |
| 4 | Dolor con penetración | 13 | Trastornos vasculares pélvicos |
| 5 | Vejiga dolorosa e hiperactiva | 14 | Infección urinaria recurrente |
| 6 | Sangrado anormal y miomas | 15 | Cáncer pélvico |
| 7 | Dolor vesical y síndromes superpuestos | 16 | Enfermedad inflamatoria intestinal |
| 8 | Pudendo y neuropatías pélvicas | 17 | Salud urogenital trans |
| 9 | Dolor pélvico masculino y prostatitis | 18 | Uretra y reconstrucción |

DÍA 2 · VIERNES 18 DE FEBRERO

**14** sesiones

## II. Sistema nervioso, dolor y tratamiento

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | Mecanismos del dolor | 26 | Neuroanatomía y pares craneales |
| 20 | Neurociencia del dolor crónico | 27 | Abordaje craneosacral |
| 21 | Trauma y atención informada | 28 | Postura, diafragma y vísceras |
| 22 | Educación del dolor | 29 | Fascia e hipermovilidad |
| 23 | Glía, neuroinflamación y mitocondrias | 30 | Tratamiento intervencionista |
| 24 | Optogenética | 31 | Neurourología y neuromodulación |
| 25 | Sistema autónomo, vago y endometriosis | 32 | Intestino irritable y dolor visceral |

# Cuatro ejes clínicos, sesenta sesiones.

## DÍA 3 · SÁBADO 19 DE FEBRERO

**13** sesiones

### III. Microbiota, hormonas y salud a lo largo de la vida

33 Microbiota intestinal e inmunidad
34 Microbiota y dolor ginecológico
35 Microbiota urinaria y vaginal
36 Envejecimiento saludable y ritmos circadianos
37 Menopausia y síndrome genitourinario
38 Seguridad hormonal
39 SOP, metabolismo y obesidad
40 Menopausia, músculo y hueso
41 Insuficiencia ovárica prematura
42 Exposoma y fertilidad masculina
43 Endometriosis e infertilidad
44 Mitocondrias y reparación tisular
45 Dispositivos y terapias emergentes

## DÍA 4 · DOMINGO 20 DE FEBRERO

**15** sesiones

### IV. Recuperación, continencia y casos integrados

46 Entrenamiento del suelo pélvico femenino
47 Continencia tras prostatectomía
48 Evaluación urológica funcional
49 Cirugía de incontinencia femenina
50 Prolapso, pesarios y mallas
51 Estreñimiento e incontinencia fecal
52 Embarazo y parto
53 Diástasis y retorno al deporte
54 Dolor posparto y cicatrices
55 Infancia y adolescencia
56 Sexualidad y pareja
57 Mutilación genital y violencia sexual
58 Recuperación tras cáncer pélvico
59 Personas mayores
60 Caso integrado con pacientes

# I. Patologías pélvicas y urogenitales

| Nº | SESIÓN Y ALCANCE | PONENTE O PERFIL PROPUESTO |
|---|---|---|
| 1 | **Endometriosis**<br>Diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico, recurrencia y continuidad. | Charles Chapron o María Ángeles Martínez-Zamora · ginecología |
| 2 | **Adenomiosis e imagen**<br>Ecografía, resonancia y diagnóstico diferencial. | Mathew Leonardi · ginecología, o Anne-Elodie Millischer · radiología |
| 3 | **Vulvodinia, vestibulodinia, liquen y otras dermatosis vulvares** | Andrew T. Goldstein · ginecología |
| 4 | **Dolor con penetración**<br>Factores vulvares, hormonales, musculares y psicosexuales. | Rachel Rubin · urología y medicina sexual, con Goldstein, Mélanie Morin · fisioterapia, y sexología según formato |
| 5 | **Vejiga dolorosa, vejiga hiperactiva e incontinencia mixta**<br>Fenotipos, medidas conservadoras, medicación y procedimientos. | Henry Lai · urología, u Oriol Porta Roda · uroginecología |
| 6 | **Sangrado anormal, miomas y patología endometrial**<br>Indicaciones de estudio y derivación. | Haitham Hamoda o Antonio Cano · ginecología |
| 7 | **Dolor vesical y síndromes superpuestos**<br>Síntomas intestinales, fibromialgia y dolor generalizado. | Michel Pontari · urología |

# I. Patologías pélvicas y urogenitales

| Nº | SESIÓN Y ALCANCE | PONENTE O PERFIL PROPUESTO |
|---|---|---|
| 8 | **Pudendo y neuropatías pélvicas**<br>Evaluación, abordaje conservador, intervencionismo y cirugía. | Marc Possover · cirugía neuropélvica, con Thibault Riant o Amélie Levesque · dolor |
| 9 | **Dolor pélvico masculino, prostatitis, dolor escrotal crónico y posvasectomía** | Michel Pontari o Quentin Clemens · urología |
| 10 | **Andrología y medicina sexual**<br>Erección, eyaculación precoz o retardada, Peyronie, hipogonadismo y testosterona. | Urología andrológica y sexología por seleccionar |
| 11 | **Hiperplasia benigna de próstata, obstrucción, retención y síntomas urinarios masculinos**<br>Alternativas médicas y quirúrgicas. Evaluación de la nocturia y criterios de derivación ante hematuria, litiasis, masas o retención. | Urología funcional por seleccionar |
| 12 | **Cadera, ingle y pubalgia en el diagnóstico diferencial** | Miguel Vázquez Gómez · traumatología |
| 13 | **Trastornos vasculares pélvicos**<br>Patología venosa, compresiones y derivación. | Miguel Ángel de Gregorio · radiología intervencionista |
| 14 | **Infección urinaria recurrente y complicada, prevención y uso de antibióticos**<br>VPH e ITS en aportación diferenciada. | Linda Brubaker · uroginecología, Aureli Torné Bladé · ginecología, e infectología según alcance |

# I. Patologías pélvicas y urogenitales

| Nº | SESIÓN Y ALCANCE | PONENTE O PERFIL PROPUESTO |
|---|---|---|
| 15 | **Cáncer pélvico**<br>Próstata, vejiga, tumores ginecológicos y colorrectales, preservación de función y continuidad asistencial. | Josep Maria Gaya Sopena · urología, Francesc Salvà · oncología, y perfiles ginecológico y radioterápico por seleccionar |
| 16 | **Enfermedad inflamatoria intestinal y patología anal**<br>Crohn, fístulas, fisura, hemorroides y diagnóstico diferencial. | Julià Panés o Eugeni Ricart · gastroenterología, y Eloy Espín Basany · cirugía colorrectal |
| 17 | **Salud urogenital trans y de género diverso**<br>Hormonación, vaginoplastia, faloplastia, complicaciones y rehabilitación pre y posoperatoria. Síntomas urinarios y sexuales, dolor y cambios de los tejidos asociados a la hormonación. | Equipo médico y funcional con experiencia específica por seleccionar |
| 18 | **Uretra y reconstrucción**<br>Estenosis, divertículo, fístulas urinarias y complicaciones posquirúrgicas. | Urología reconstructiva y uroginecología por seleccionar |

# II. Sistema nervioso, dolor y tratamiento

| Nº | SESIÓN Y ALCANCE | PONENTE O PERFIL PROPUESTO |
|---|---|---|
| 19 | **Mecanismos y evaluación del dolor nociceptivo, neuropático y nociplástico** | Daniel Clauw · reumatología e investigación |
| 20 | **Neurociencia del dolor crónico**<br>Cerebro, miedo, trauma, eje intestino–cerebro, meditación y MBSR en una conferencia ampliada. | Javier García Campayo · psiquiatría |
| 21 | **Atención informada por trauma**<br>Consentimiento, exploración íntima, dolor sexual, miedo y evitación. | Lindsey McKernan · psicología clínica. Mark Lumley como alternativa o aportación diferenciada |
| 22 | **Educación del dolor, comunicación y autonomía** | Lorimer Moseley · fisioterapia e investigación |
| 23 | **Glía, neuroinflamación y mitocondrias en dolor persistente** | Ru-Rong Ji · investigación traslacional |
| 24 | **Optogenética en circuitos de vejiga y dolor**<br>Descubrimientos reconocidos con el Nobel de Fisiología o Medicina 2026 a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel. Aplicaciones experimentales. | Georg Nagel · biofísica, Aaron Mickle o Robert Gereau · neurociencia |
| 25 | **Sistema autónomo, vago y endometriosis**<br>Investigación y valoración manual en aportaciones diferenciadas. | Sun-Wei Guo · investigación, Eric Marlien · osteopatía |
| 26 | **Neuroanatomía, pares craneales y conexiones corporales**<br>Perspectiva manual. | Alain Croibier · osteopatía |

# II. Sistema nervioso, dolor y tratamiento

| Nº | SESIÓN Y ALCANCE | PONENTE O PERFIL PROPUESTO |
|---|---|---|
| 27 | **Perspectiva craneosacral en atención multidisciplinar**<br>Alcance clínico y evidencia. | Docente del Upledger Institute por designar |
| 28 | **Postura, diafragma y relaciones viscerales en dolor pélvico** | Mark Bloemberg · fisioterapia y osteopatía |
| 29 | **Fascia, dolor miofascial, hipermovilidad y Ehlers-Danlos**<br>Valoración, coordinación y adaptación del ejercicio. | Antonio Stecco · medicina física y rehabilitación, con perfil específico de hipermovilidad según alcance |
| 30 | **Tratamiento médico e intervencionista**<br>Medicación, tratamientos intravesicales, infiltraciones y bloqueos. Dolor posquirúrgico y selección de pacientes. Revisión diferenciada de instilaciones vesicales y toxina botulínica según diagnóstico e indicación. | Thibault Riant o Amélie Levesque · dolor, con urología para tratamiento vesical |
| 31 | **Neurourología y neuromodulación**<br>Vejiga e intestino en lesión medular, esclerosis múltiple y Parkinson. Estimulación tibial o sacra según indicación. | Jalesh Panicker · neurología, y urología funcional |
| 32 | **Intestino irritable, dolor visceral y anorrectal funcional**<br>Proctalgia, elevador del ano y coccigodinia. | Jordi Serra Pueyo o Adil Bharucha · gastroenterología, con coloproctología |

# III. Microbiota, hormonas y longevidad

| Nº | SESIÓN Y ALCANCE | PONENTE O PERFIL PROPUESTO |
|---|---|---|
| 33 | **Microbiota intestinal, barrera, inmunidad y metabolómica** | Alessio Fasano · gastroenterología pediátrica e investigación |
| 34 | **Inflamación, microbiota y dolor ginecológico** | Omero Poli-Neto · ginecología e investigación |
| 35 | **Microbiota urinaria y vaginal, micobioma, colonización e infección** | A. Lenore Ackerman · urología. Alan Wolfe · microbiología, o Linda Brubaker · uroginecología, según enfoque |
| 36 | **Envejecer bien empieza por cuidar la función de nuestros órganos**<br>Ritmos circadianos, horario de comidas y bebidas, menopausia, función vesical y descanso. Evaluación médica de la nocturia en 11, 31 y 48. Salud urogenital y longevidad. Cómo intervienen los cambios hormonales de la menopausia en el sueño y cómo se relacionan el descanso, los ritmos circadianos y los horarios de alimentación con la salud metabólica y la función urogenital. | Xevi Verdaguer · fisioterapia y psiconeuroinmunología |
| 37 | **Menopausia y síndrome genitourinario**<br>Síntomas urinarios, sexuales y tratamiento individualizado. | Rossella Nappi, Haitham Hamoda o Antonio Cano · ginecología |
| 38 | **Seguridad hormonal, alternativas no hormonales y antecedentes oncológicos** | Especialista seleccionado para menopausia. Nick Panay como alternativa |

# III. Microbiota, hormonas y longevidad

| Nº | SESIÓN Y ALCANCE | PONENTE O PERFIL PROPUESTO |
|---|---|---|
| 39 | **SOP, obesidad, diabetes, cambios de peso y cirugía bariátrica en relación con síntomas urinarios, sexuales y funcionales** | Helena Teede o Lourdes Ibáñez Toda · endocrinología, con cobertura adulta según enfoque |
| 40 | **Menopausia, fuerza, músculo, tejido conectivo y salud ósea**<br>Cognición y repercusión funcional como contenido complementario. | Mark Brincat o Eu-Leong Yong · ginecología, con perfil adicional según alcance |
| 41 | **Insuficiencia ovárica prematura y menopausia quirúrgica** | Nick Panay · ginecología, o Amanda Vincent · endocrinología |
| 42 | **Exposoma, disruptores endocrinos, microplásticos y fertilidad masculina** | Luigi Montano · urología y andrología |
| 43 | **Endometriosis, adenomiosis e infertilidad**<br>Reserva ovárica, cirugía frente a FIV y preservación de fertilidad, incluida oncofertilidad. | Reproducción asistida, ginecología y oncología por seleccionar |
| 44 | **Mitocondrias, envejecimiento celular y reparación tisular**<br>Macrófagos con perfiles reparadores, incluidos los denominados M2, y resolución de la inflamación. Investigación y pasos necesarios para su aplicación urogenital. | Volkmar Weissig · farmacología y medicina mitocondrial, con investigador de reparación por seleccionar |

# III. Microbiota, hormonas y longevidad

| Nº | SESIÓN Y ALCANCE | PONENTE O PERFIL PROPUESTO |
|---|---|---|
| 45 | **Dispositivos y terapias emergentes**<br>Láser, radiofrecuencia, ondas de choque, estimulación electromagnética, PRP y exosomas. Evidencia, seguridad, indicaciones y límites. Revisión de biomarcadores y grado de desarrollo de las propuestas regenerativas, con distinción entre resultados experimentales y clínicos. | Panel médico e investigador por seleccionar |

# IV. Recuperación, continencia y casos

| Nº | SESIÓN Y ALCANCE | PONENTE O PERFIL PROPUESTO |
|---|---|---|
| 46 | **Entrenamiento del suelo pélvico femenino**<br>Incontinencia, prolapso y deporte de impacto. Telerrehabilitación, aplicaciones y diarios digitales para el seguimiento del ejercicio. | Kari Bø · fisioterapia e investigación. Conferencia individual |
| 47 | **Continencia masculina y recuperación tras prostatectomía**<br>Control motor y entrenamiento individualizado. | Paul Hodges · fisioterapia e investigación. Conferencia individual |
| 48 | **Evaluación urológica funcional**<br>Diario miccional, nocturia, residuo, flujometría, urodinámica, ecografía, vaciado y retención femenina. Papel de enfermería de continencia en educación, cateterismo y seguimiento. IA aplicada a imagen y evaluación, utilidad clínica y privacidad. | Carlos Errando como candidato · urología, y David Sánchez Rienda · fisioterapia y osteopatía, con funciones diferenciadas |
| 49 | **Cirugía de incontinencia femenina**<br>Cabestrillos, alternativas sin malla, rellenos, recurrencia y complicaciones. | Urología o uroginecología quirúrgica por seleccionar |
| 50 | **Prolapso, pesarios y complicaciones de mallas**<br>Selección, autocuidado, seguimiento y reconstrucción. Adaptación del pesario, complicaciones y educación para el autocuidado con enfermería de continencia. | Marianna Alperin o Rohna Kearney · uroginecología, con enfermería y cirugía reconstructiva |
| 51 | **Estreñimiento, disinergia e incontinencia fecal**<br>Motilidad, biofeedback, rehabilitación y cirugía. Papel de nutrición en el abordaje coordinado del estreñimiento y los síntomas intestinales. | Jordi Serra Pueyo o Adil Bharucha · gastroenterología, y Eloy Espín Basany · coloproctología |

# IV. Recuperación, continencia y casos

| Nº | SESIÓN Y ALCANCE | PONENTE O PERFIL PROPUESTO |
|---|---|---|
| 52 | **Embarazo y parto**<br>Dolor de cintura pélvica, preparación, desgarros del esfínter anal y lesión del elevador. | Obstetricia, matrona y fisioterapia especializada |
| 53 | **Diástasis abdominal y retorno al deporte posparto** | Gráinne Donnelly · fisioterapia. Conferencia individual propuesta |
| 54 | **Dolor posparto, cicatrices y recuperación**<br>Cicatrices perineales y abdominales, dolor y criterios de derivación. | Élise Bouyssou · osteopatía. Conferencia individual propuesta |
| 55 | **Infancia, adolescencia y transición**<br>Continencia, vejiga e intestino neurógenos y diferencias del desarrollo sexual con especialista específico. | Giovanni Mosiello · urología pediátrica, con endocrinología y equipo pediátrico |
| 56 | **Sexualidad y pareja**<br>Deseo, excitación, orgasmo, efectos de medicamentos y adaptación tras enfermedad o cirugía. | Rachel Rubin · urología y medicina sexual, sexología y psicología |
| 57 | **Mutilación genital femenina y violencia sexual**<br>Atención especializada, reconstrucción cuando proceda y recuperación informada por trauma. | Equipo médico especializado, psicología, sexología y rehabilitación |

# IV. Recuperación, continencia y casos

| Nº | SESIÓN Y ALCANCE | PONENTE O PERFIL PROPUESTO |
|---|---|---|
| 58 | **Recuperación después del cáncer pélvico**<br>Radioterapia, fibrosis, estenosis, ostomías, síndrome de resección anterior baja y función sexual y urinaria. Cuidados de ostomía y repercusiones intestinales, urinarias y sexuales del tratamiento. | Oncología, cirugía, rehabilitación y enfermería de ostomías |
| 59 | **Salud pélvica en personas mayores**<br>Fragilidad, deterioro cognitivo, polimedicación, continencia y cuidadores. Adaptación del seguimiento y apoyo a cuidadores. | Geriatría, urología y enfermería. Dawn Skelton como posible aportación sobre ejercicio |
| 60 | **Caso integrado con pacientes y asociaciones**<br>Objetivos compartidos, decisiones y resultados que importan. Medidas de resultado de dolor, función urinaria, intestinal y sexual, actividad y calidad de vida. Acceso, derivación y continuidad asistencial. | Equipo clínico y representantes de pacientes por acordar |

# Programa de talleres

| Nº | TALLER | DURACIÓN | RESPONSABLE PROPUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | **Valoración manual urogenital** | **4 h** | Marc Naudin · Olivier Bazin como reserva |
| 2 | **Relaciones vasculares pélvicas y valoración manual** | **4 h** | Mark Bloemberg |
| 3 | **Inducción miofascial aplicada al suelo pélvico** | **4 h** | Andrzej Pilat |
| 4 | **Manipulación Fascial aplicada a disfunciones pélvicas** | **4 h** | Antonio Stecco |
| 5 | **Endometriosis y adenomiosis: casos e informes operatorios en el abordaje osteopático** | **4 h** | Colette Peeters |
| 6 | **Recuperación funcional posparto** | **4 h** | Élise Bouyssou |
| 7 | **Regulación autonómica: enfoque manual vagal o polivagal** | **3 h** | Eric Marlien o Matías Fernando Chahab |
| 8 | **Educación del dolor en consulta: casos de dolor pélvico** | **3 h** | Lorimer Moseley, según disponibilidad |
| 9 | **Evaluación ecográfica y funcional del suelo pélvico** | **2 h** | David Sánchez Rienda · alcance a concretar |
| 10 | **Neuromodulación tibial: selección y aplicación práctica** | **2 h** | A concretar |
| 11 | **Pesarios: selección, adaptación y autocuidado** | **2 h** | A concretar (uroginecología y enfermería de continencia) |
| 12 | **Biofeedback y electroestimulación en la rehabilitación del suelo pélvico** | **2 h** | A concretar |
| 13 | **Silla de estimulación magnética del suelo pélvico (estimulación magnética funcional): demostración práctica** | **1 h** | A concretar |

*Duración de 1 a 4 horas · 4 h: 300 € · 3 h: 225 € · 2 h: 150 € · 1 h: por confirmar · Se adquieren aparte de la inscripción. Precios provisionales, IVA incluido.*

# Especialidades médicas

## GINECOLOGÍA Y RADIOLOGÍA

- CC **Charles Chapron** — Ginecología
- MÁ **María Ángeles Martínez-Zamora** — Ginecología
- ML **Mathew Leonardi** — Ginecología
- AG **Andrew T. Goldstein** — Ginecología
- HH **Haitham Hamoda** — Ginecología
- AC **Antonio Cano** — Ginecología
- RN **Rossella Nappi** — Ginecología
- NP **Nick Panay** — Ginecología
- MB **Mark Brincat** — Ginecología
- EY **Eu-Leong Yong** — Ginecología
- OP **Omero Poli-Neto** — Ginecología e investigación
- AT **Aureli Torné Bladé** — Ginecología
- AM **Anne-Elodie Millischer** — Radiología
- MÁ **Miguel Ángel de Gregorio** — Radiología intervencionista

## UROLOGÍA Y UROGINECOLOGÍA

- RR **Rachel Rubin** — Urología y medicina sexual
- HL **Henry Lai** — Urología
- MP **Michel Pontari** — Urología
- QC **Quentin Clemens** — Urología
- JM **Josep Maria Gaya Sopena** — Urología
- LA **A. Lenore Ackerman** — Urología
- CE **Carlos Errando** — Urología funcional
- LM **Luigi Montano** — Urología y andrología
- GM **Giovanni Mosiello** — Urología pediátrica
- OP **Oriol Porta Roda** — Uroginecología
- LB **Linda Brubaker** — Uroginecología
- MA **Marianna Alperin** — Uroginecología
- RK **Rohna Kearney** — Uroginecología

# Especialidades médicas e investigación

## DIGESTIVO, DOLOR Y NEUROCIENCIAS

- JP **Julià Panés** — Gastroenterología
- ER **Eugeni Ricart** — Gastroenterología
- JS **Jordi Serra Pueyo** — Gastroenterología
- AB **Adil Bharucha** — Gastroenterología
- AF **Alessio Fasano** — Gastroenterología pediátrica
- EE **Eloy Espín Basany** — Cirugía colorrectal
- MP **Marc Possover** — Cirugía neuropélvica
- TR **Thibault Riant** — Medicina del dolor
- AL **Amélie Levesque** — Medicina del dolor
- JP **Jalesh Panicker** — Neurología
- DC **Daniel Clauw** — Reumatología
- JG **Javier García Campayo** — Psiquiatría
- LM **Lindsey McKernan** — Psicología clínica
- ML **Mark Lumley** — Psicología clínica

## ENDOCRINO, ONCOLOGÍA Y TRAUMA

- HT **Helena Teede** — Endocrinología
- LI **Lourdes Ibáñez Toda** — Endocrinología pediátrica
- AV **Amanda Vincent** — Endocrinología
- FS **Francesc Salvà** — Oncología médica
- MV **Miguel Vázquez Gómez** — Traumatología

## INVESTIGACIÓN

- RJ **Ru-Rong Ji** — Investigación traslacional del dolor
- GN **Georg Nagel** — Biofísica
- AM **Aaron Mickle** — Neurociencia
- RG **Robert Gereau** — Neurociencia
- SG **Sun-Wei Guo** — Investigación en endometriosis
- AW **Alan Wolfe** — Microbiología
- VW **Volkmar Weissig** — Medicina mitocondrial

# Fisioterapia, rehabilitación y osteopatía

## FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

- KB **Kari Bø** — Fisioterapia e investigación
- PH **Paul Hodges** — Fisioterapia e investigación
- LM **Lorimer Moseley** — Fisioterapia y neurociencia del dolor
- GD **Gráinne Donnelly** — Fisioterapia
- MM **Mélanie Morin** — Fisioterapia
- AP **Andrzej Pilat** — Fisioterapia
- AS **Antonio Stecco** — Medicina física y rehabilitación
- XV **Xevi Verdaguer** — Fisioterapia y psiconeuroinmunología
- DS **Dawn Skelton** — Ejercicio y envejecimiento

## OSTEOPATÍA

- AC **Alain Croibier** — Osteopatía
- EM **Eric Marlien** — Osteopatía
- ÉB **Élise Bouyssou** — Osteopatía
- CP **Colette Peeters** — Osteopatía
- MN **Marc Naudin** — Osteopatía
- MF **Matías Fernando Chahab** — Osteopatía
- MB **Mark Bloemberg** — Fisioterapia y osteopatía
- DS **David Sánchez Rienda** — Fisioterapia y osteopatía
- OB **Olivier Bazin** — Fisioterapia y osteopatía

TARIFAS

# Tres tramos de precio, dos modalidades.

Precios provisionales, IVA incluido. La tarifa se aplica según la fecha de pago.

## PRESENCIAL · AUDITORI AXA

| | | |
|---|---|---|
| **Early Bird** | Hasta el 31 de diciembre de 2027 · congreso, 4 días | **640 €** |
| **Reducida** | Hasta el 18 de enero de 2028 | **720 €** |
| **General** | Último mes | **800 €** |

## STREAMING · SIN LÍMITE DE AFORO

| | | |
|---|---|---|
| **Early Bird** | Emisión en directo de todas las ponencias | **350 €** estudiantes 300 € |
| **Reducida** | Preguntas a los ponentes por chat | **400 €** estudiantes 350 € |
| **General** | Acceso personal e intransferible | **450 €** estudiantes 400 € |

### TALLERES Y EXTRAS

Talleres prácticos (aparte, solo presenciales): 4 h · 300 € 3 h · 225 € 2 h · 150 € 1 h · por confirmar. Descuento del 5 % por 2 o 3 talleres y del 15 % por 4 o más. Pack de grabaciones durante 12 meses: +150 € con la entrada.

# Comunicaciones orales y pósteres

Presentación de trabajos de investigación y casos clínicos. Las comunicaciones mejor valoradas se presentarán en formato oral; el resto, como póster.

## Áreas temáticas

- Patología urológica y uroginecológica
- Suelo pélvico femenino y masculino
- Dolor pélvico crónico y neurociencia del dolor
- Embarazo, parto y posparto
- Menopausia y salud urogenital
- Microbiota, hormonas y longevidad
- Abordaje visceral, osteopático y fisioterapéutico
- Casos clínicos integrados

## Normas de envío

- Máximo 300 palabras
- En español o en inglés
- Introducción, objetivos, método, resultados y conclusiones
- Formato: comunicación oral o póster
- Al menos un autor inscrito en el congreso

## Calendario

**Apertura de la convocatoria**

Por confirmar

**Fecha límite de envío**

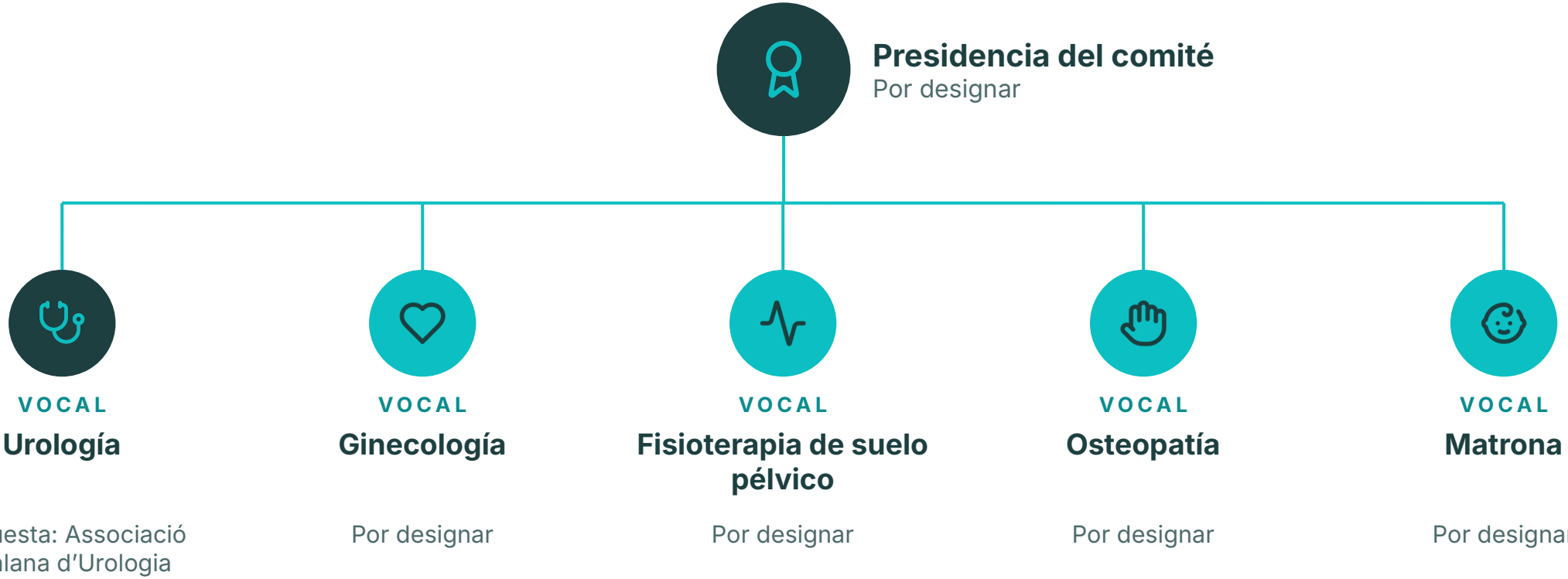
Por confirmar

**Notificación de aceptación**

Por confirmar

*Evaluación anónima por el comité científico y premios a las mejores comunicaciones.*

# Comité médico y científico




**Funciones:** definir las prioridades clínicas del programa, proponer ponentes, evaluar de forma anónima las comunicaciones y conceder los premios científicos.

# Avales, patrocinadores y colaboradores

## AVALES CIENTÍFICOS

Sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones

- Associació Catalana d'Urologia (propuesta)
- Entidad avaladora
- Entidad avaladora
- Entidad avaladora

## PATROCINADORES

Categorías oro, plata y bronce

- Oro
- Oro
- Plata
- Plata
- Bronce

## COLABORADORES

Universidades, hospitales y empresas del sector

- Colaborador
- Colaborador
- Colaborador
- Colaborador
- Colaborador
- Colaborador

*Espacios disponibles. Información sobre patrocinio: contacto@walambcn.com*

PRÓXIMOS PASOS

# Lo que hace falta para convertir esta propuesta en un congreso.

**01**

**PRIORIZAR**

Acordar con l'Associació Catalana d'Urologia las prioridades clínicas del programa.

**02**

**CONSTITUIR**

Configurar el comité médico y científico y su presidencia.

**03**

**CONFIRMAR**

Ponentes, sede, fechas y presupuesto definitivos.

**04**

**LANZAR**

Abrir inscripciones, convocatoria de comunicaciones y patrocinio.

**UN PROYECTO QUE CRECE CON SUS SOCIOS**

La propuesta se construye de forma conjunta: la Associació aporta la visión urológica y el criterio científico; WA LAM, la organización, la red de profesionales y la experiencia formativa.

PROPUESTA DE COLABORACIÓN

# Una red de profesionales de referencia, unidos en beneficio del paciente.

Definir conjuntamente las prioridades clínicas del congreso y la participación de l'Associació Catalana d'Urologia en el comité científico.

**Barcelona**

AUDITORI AXA

**17–20 feb**

2028 · FECHAS PREVISTAS

**Rosa María Rodríguez Valls**

Fundadora y directora de WA LAM

contacto@walambcn.com · www.walambcn.com